

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

JERÔNIMO FORTES

IDADE: 73 PESO: 76 ALTURA: 172 PROFISSÃO:

SINTOMAS:

QUEIXAS: sonolência diurna / memória

MEDICAMENTOS: Rosartona / fardiam /

HAS / DM / Hipertrofia de próstata

MÉDICO: Drº Jerônimo

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: natação (2x) / musculação / alongamento

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S 19-20hs

HORA QUE DORME: 23:30 HORA QUE ACORDA: 7hs

COCHILLO () SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 30 anos

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 4x fumou 40 anos

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 80,4 e/e SPO2: 92% / 82%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: 2006 - reocorreu aórtica

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Reuse / skat.

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS Herma Disco Bulbar

10/04 Insônia de manipulação * Tempo apnéia

24 Microdesp. 12,2 e/e IAH = 80,4 e/e - 51,6 IA / 28,8 IH. 51,6

doação

max N30i tubotomied

18/04 D. Dorsal na maioria das vezes.

24 melhora dos sintomas de sonolência

10/06 Fez cirurgia de troca de válvula

04/09 TROCOU A MASC. P/ NASAL DREAM Pillow.

16/10 P = 8.7 em 160

25 IAH = 1.7 e/e

M. de uso = 8h 20'

fuqcu = 4.5

fuq claudis



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Antonio Jeronimo Guimarães Fortes

EXAME nº: 5586

SOLICITADO POR: Dr. Antonio Jeronimo Guimarães Fortes

DATA 27/03/2024

IDADE: 73 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

Comentários:

Exame iniciado às 22h21min e concluído às 06h31min. A latência para o sono foi de 3 minutos e a latência para o estágio REM, de 59 minutos. O tempo total de sono foi de 460,5 minutos (07h40min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 95,1%. A distribuição do sono mostrou 14,7% de estágio 1, 64,6% de estágio 2, 5,6% de estágio 3 e 15,1% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 20,5 minutos em vigília, ocorreram 94 microdespertares (índice: 12,2/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 80,4/hora, sendo 51,6 apneia/hora e 28,8 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 80,4/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 92% e a mínima de 82%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (80,4/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (80,4/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o decúbito dorsal, e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 51; máxima: 72 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 3 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava encurtada (59 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (95,1%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (12,2/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (14,7%; normal: 8-10%) e 2 (64,6%; normal: 45-55%), e a redução dos estágios 3 (5,6%; normal: 10-12%) e REM (15,1%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 17 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730